SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0810463-97.2025.8.15.0001
AUTOR: MARIA LINDACI TORRES DI PACE
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIA IDOSA (87 ANOS) DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO, COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES E DEPENDÊNCIA TOTAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO HOME CARE INTEGRAL (24 HORAS) COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E INSUMOS. RECUSA DA OPERADORA PAUTADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E EM AVALIAÇÃO INTERNA (TABELA ABEMID) QUE NÃO PREVALECE SOBRE O LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECONHECIMENTO DE QUE O HOME CARE CONSTITUI EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTS. 47 E 51, IV). ABUSIVIDADE DA NEGATIVA OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE E À VIDA DA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO URGENTE E VITAL, QUE AGRAVA A AFLIÇÃO E ANGÚSTIA DO PACIENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA E MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada por **MARIA LINDACI TORRES DI PACE** em face de **UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**, ambos devidamente qualificados nos autos.

A Autora narra ser usuária do plano de saúde da Ré e, em razão de seu avançado estado de saúde – 87 anos de idade (Id. 109748059), com diagnóstico de Doença de Alzheimer em estágio grave (FAST 7E), declínio cognitivo severo, dependência total para as atividades da vida diária, síndrome da imobilidade, disfagia em uso de gastrostomia e histórico de broncoaspiração necessitando de tratamento domiciliar (home care) integral 24 horas. Para fundamentar sua pretensão, apresentou **laudo médico circunstanciado (Id. 109750265)** indicando a necessidade de assistência multidisciplinar contínua, incluindo equipe de enfermagem 24h, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutricionista, visita médica, aparelho de aspiração, dieta enteral hipercalórica e normoproteica, e fraldas geriátricas.

Afirma que, após solicitação administrativa, a Unimed autorizou apenas fisioterapia e serviço de enfermagem limitado a 12 horas diárias, o que considera insuficiente e arriscado para sua saúde. Pugna pela concessão da tutela de urgência para o fornecimento integral do home care 24h e, ao final, pela procedência dos pedidos para a confirmação da obrigação de fazer e condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Petição Inicial, Id. 109748059, pág. 6).

Tutela de urgência foi deferida pelo juízo de primeiro grau, determinando o fornecimento integral dos serviços de assistência domiciliar 24h, conforme laudo médico da Autora (Decisão, Id. 110654586).

A Ré interpôs Agravo de Instrumento contra essa decisão, mas o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (Acórdão, Id. 116055763, pág. 1-12, referente ao Agravo de Instrumento n.º 0807756-62.2025.8.15.0000), mantendo a decisão que concedeu a tutela de urgência.

A Unimed C. Grande Cooperativa de Trabalho Médico LTDA apresentou Contestação (Id. 111490979), na qual, preliminarmente, não arguiu questões processuais. No mérito, alegou, em síntese: a) que não houve negativa de cobertura, mas sim uma discussão sobre a natureza e extensão dos serviços b) que a assistência solicitada para 24h de enfermagem se confunde com o serviço de cuidador, o qual não possui cobertura contratual, citando a Resolução 11/2006 da ANVISA; c) que a necessidade do home care integral não foi comprovada, e a avaliação pela tabela ABEMID, utilizada internamente, não justificaria a intensidade do tratamento pleiteado, mas sim acompanhamento por cuidador; d) que, em todo caso, os serviços solicitados não possuem cobertura contratual ou legal, agindo a Ré no exercício regular de seu direito; e) a inexistência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento contratual

A Autora apresentou Impugnação à Contestação (Id. 111551394), reiterando seus pedidos, refutando os argumentos da Ré e solicitando o julgamento antecipado da lide, bem como a apresentação de planilha de custos pela Unimed.

O processo foi redistribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 – Saúde Suplementar, com competência absoluta para julgar a matéria (Decisão, Id. 122626941, pág. 1-2), conforme certificado em 09/12/2025 (Id. 128674849, pág. 1).

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Verifica-se que a controvérsia posta nestes autos cinge-se a matéria de direito e de fato, sendo esta última **suficientemente comprovada por meio da documentação acostada, a qual se revela apta a embasar o deslinde da demanda**.

A **real necessidade da internação domiciliar e a complexidade da assistência exigida já se encontram fartamente demonstradas** pelos elementos probatórios constantes nos autos, notadamente o **laudo médico circunstanciado apresentado pela médica assistente da Autora (Id. 109750265)**. Este documento atesta de forma clara e detalhada a gravidade do quadro clínico da Autora e a imprescindibilidade do tratamento home care integral, incluindo a equipe de enfermagem 24 horas. Tal prova, ademais, já foi objeto de análise e reconhecimento judicial em fases anteriores do processo.

A **tutela de urgência foi deferida (Id. 110654586)** com base na plausibilidade do direito da Autora, e a decisão foi **integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (Acórdão, Id. 116055763)** em sede de Agravo de Instrumento.

Dessa forma, diante da **clareza e suficiência da prova documental já produzida**, que inclui a indicação médica especializada e o reconhecimento judicial prévio da urgência e da probabilidade do direito, entende-se que **a produção de prova pericial torna-se desnecessária e protelatória**, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

O magistrado, como destinatário da prova, deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do Art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentir:

> “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ. Colenda Quarta Turma, REsp 2.832-RJ, Relator o Exmo. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.1990, p. 9.513 ob. cit., p. 392).
>
> "O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2a Turma - AI 203.793-5-MG, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, DJU 19.12.97, p. 53)

Verifico que o processo se encontra em ordem e que não há nulidades a serem sanadas de ofício, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual decido julgar antecipadamente a presente causa."

2. DO MÉRITO

De início, impõe-se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Art. 35-G da Lei n.º 9.656/1998. Trata-se de contrato de adesão, em que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do Art. 47 do CDC. As cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas de pleno direito (Art. 51, IV, do CDC).

A Unimed argumenta que a avaliação pela tabela ABEMID não justificaria a internação domiciliar completa, mas sim o acompanhamento por cuidador, e que tal tabela seria um critério técnico balizador.

No entanto, o **laudo médico (Id. 109750265)**, subscrito pela médica assistente da Autora, Dra. Aila Maiara Albuquerque, é cristalino ao descrever o quadro clínico grave e a **necessidade expressa de "EQUIPE DE ENFERMAGEM 24 HORAS"**, além de outros serviços multidisciplinares. A Autora é uma paciente idosa, com 87 anos, portadora de Doença de Alzheimer em estágio grave (FAST 7E), dependência total para atividades da vida diária, disfagia em uso de gastrostomia e histórico de broncoaspiração, condições que exigem vigilância e assistência contínua e especializada.

O laudo médico (Id. 109750265) e a gravidade do quadro clínico da Autora, que exige cuidados técnicos e contínuos, **impedem a substituição da equipe de enfermagem por cuidadores leigos**, dadas as complexidades da patologia e a necessidade de procedimentos médicos específicos.

Conforme já destacado na decisão de tutela de urgência e no acórdão que a manteve:

> **Decisão (Id. 110654586)**: "O argumento da ré quanto à suficiência da cobertura com base na pontuação da tabela ABEMID não se mostra, neste momento, capaz de afastar a urgência da medida pleiteada. Isso porque não consta dos autos que tenha sido realizada visita presencial por profissional da Unimed para avaliação da paciente... **A ABEMID é instrumento administrativo sem força normativa vinculante, cuja aplicação por si só não substitui o laudo clínico do médico assistente.**" (grifo nosso).
>
> **Acórdão (Id. 116055763)**:

> "Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) é legítima quando demonstrada a prescrição médica expressa e a urgência clínica. 2. **A tabela ABEMID não possui caráter normativo e não prevalece sobre o laudo médico do profissional assistente**." (grifo nosso)

É imperioso notar que o conjunto destes cuidados extrapola em muito as capacidades e responsabilidades de um "cuidador" leigo, social ou familiar, exigindo, sem sombra de dúvidas, a expertise de um *profissional técnico de enfermagem*. Este profissional deve ser capaz de realizar tarefas vitais, medição de glicose, realização de curativos e monitoramento de sinais de infecções, que compõem o esquema terapêutico da Autora.

Ademais, as decisões já proferidas nos autos são enfáticas ao considerar que o **laudo médico do profissional assistente da paciente prevalece sobre as avaliações internas do plano de saúde (como a tabela ABEMID)**, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de cuidados contínuos, como a enfermagem 24 horas. O Tribunal de Justiça da Paraíba inclusive notou que a própria Unimed, ao se manifestar no processo de origem, anexou *outro* laudo médico que "a necessidade de serviço *home care* também restou demonstrada." (*Id. 116055763, pág. 7*).

O serviço de *home care* nada mais é do que um desdobramento do atendimento hospitalar, devendo, portanto, ser fornecido à parte recorrida os mesmos cuidados acaso estivesse em tratamento hospitalar, isso, é claro, sem que haja qualquer desequilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a internação domiciliar (*home care*) representa um desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Assim, a cláusula contratual que exclui ou limita essa modalidade de assistência é considerada abusiva, por restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato de saúde.

> CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, **"é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar"** (AgInt no AREsp 1.725 .002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ . 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2615077 SP 2024/0045542-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR). RECUSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n. 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872471 SP 2021/0105240-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Na mesma linha de raciocínio, já se manifestou o Tribunal de Justiça da Paraíba:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE . SERVIÇO DE HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE . TRATAMENTO COBERTO PELO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECONHECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO OBSERVANDO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
“É entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que o serviço denominado ‘Home Care’ é uma extensão dos serviços prestados no estabelecimento hospitalar, não podendo a operadora de plano de saúde negar ao paciente, caso recomendado pelos médicos (REsp 1.378 .707/RJ).
A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de Home Care prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da paciente, uma vez que, ao ter negado o tratamento requerido que se revelava essencial à melhora de seu estado de saúde, já se encontrava em condição de dor, abalo e saúde debilitada.

> O propósito do valor indenizatório a ser arbitrado tem por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e sim, desestimular a prática desses atos ilícitos, taxando uma sanção pecuniária ao infrator, por ser responsável pelo ato que foi a causa de pedir nesta ação indenizatória, e reparar o dano sofrido por aquele que não deu causa ao evento danoso.
> (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08019926320238150001, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, publicado em 29/08/2024)
> (...) 4. O tratamento home care configura uma extensão da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa de cobertura quando indicado por profissional de saúde, conforme entendimento pacífico do STJ. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08448600720228152001, Relator.: Gabinete 01 - Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)

Desta feita, certo de que cláusulas contratuais limitativas ou restritivas devem ser interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor, a recusa a dar cobertura às despesas com o tratamento domiciliar se afigura abusiva e ilegal, inclusive porque tal método de prestação de serviço está vinculado ao tratamento cuja previsão no contrato não é negada pela seguradora.

Relevante anotar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso semelhante (RESP 1.378.707-RJ (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/198592102)), reconheceu que no caso em que o serviço de *home care* não conste expressamente do rol de coberturas previsto no contrato de plano de saúde, a operadora ainda assim será obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde que respeitados alguns requisitos:

a) tenha havido indicação do tratamento pelo médico assistente;

b) o paciente concorde com o tratamento domiciliar;

c) não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde, a exemplo dos casos em que o custo do atendimento domiciliar por dia supere a despesa diária em hospital.

Ao que se percebe, o quadro médico da paciente é delicado, necessitando de equipe de enfermagem 24h, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutricionista, visita médica, aparelho de aspiração, dieta enteral hipercalórica e normoproteica, e fraldas geriátricas. Referidos procedimentos claramente não se resumem a um cuidado básico e demandam intervenção de profissionais da saúde, tendo sido solicitado a **Unimed** a disponibilização dos serviços de *home care* 24 horas diárias. Contudo, o plano de saúde negou a solicitação, levando a requerente a intentar a demanda de origem.

Quantos aos outros dois requisitos restantes, a paciente concordou com o tratamento, tanto é assim que buscou, na esfera judicial, sua prestação e a operadora recorrente não demonstrou que a oferta do serviço lhe ocasionaria qualquer prejuízo consistente em gastos superiores ao que teria em caso de internação.

Em sendo assim, preenchidos os três requisitos impostos pelo Superior Tribunal de Justiça, verificamos que não encontra amparo a negativa da operadora agravante.

Em razão do serviço de *home care* constituir **desdobramento do atendimento hospitalar** contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado, de acordo com a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

> Súmula 302/STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Por fim, vale esclarecer que a autora tem 87 (oitenta e sete) anos de idade, encontra-se com declínio cognitivo e ALZHEIMER, com dependência total para atividades da vida diária, não sendo cabível aguardar algo mais grave acontecer para que seja deferido o serviço de assistência nos moldes em que requerido, mormente no caso em análise, em que o serviço de *home care* certamente é menos oneroso do que a própria internação hospitalar.

Logo, constata-se que o tratamento buscado é devido, tendo o plano de saúde cometido dano moral indenizado, porquanto a negativa de cobertura só fez aumentar o já alto e grave estado de sofrimento físico e mental da consumidora.

Para além, no que se refere ao dano moral, a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de *Home Care* devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis.

Destarte, não há dúvidas, acerca da ocorrência do dano moral, considerando que o delicado estado de saúde do autor/paciente, necessitando do tratamento que lhe fora prescrito, não permite que o caso seja tratado como mero aborrecimento.

Nesse sentido:

> Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.
>
> (...)
>
> III. RAZÕES DE DECIDIR
>
> Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficiente o conjunto probatório constante dos autos para formação de seu convencimento, nos termos dos arts . 370 e 371 do CPC.
>
> É abusiva a cláusula contratual que exclui o serviço de internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1872471/SP; REsp 2.017.759/MS) .
>
> Comprovado o estado de saúde do beneficiário e a recomendação médica para o tratamento domiciliar, impõe-se a obrigação da operadora de custear o serviço de home care.
>
> A recusa injustificada da cobertura, agravando a situação de vulnerabilidade do beneficiário, caracteriza dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV . DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de perícia médica não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.
É abusiva a cláusula contratual que exclui a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, impondo-se o custeio pela operadora.
A recusa indevida de cobertura médica pelo plano de saúde enseja indenização por danos morais em razão da angústia e do sofrimento causado ao beneficiário .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CPC, arts. 370 e 371; CDC, arts. 6º e 14 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1872471/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11 .09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, REsp 2 .017.759/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 15.03.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.923 .468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28 .06.2023.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08234667020248152001, Relator.: Gabinete 14 - Des. Leandro dos Santos, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Câmara Cível)

(...) Tese de julgamento: " 1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui o tratamento domiciliar (home care) prescrito como substituto à internação. 2. A recusa indevida de cobertura enseja responsabilidade civil da operadora, sendo devida indenização por danos morais, mesmo nos casos em que o óbito do paciente decorre da resistência no fornecimento do tratamento ." VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados: ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária virtual realizada, por unanimidade, desprover o recurso apelatório e prover o recurso adesivo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08538031320228152001, Relator.: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, publicado em 24/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Para a quantificação, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o caráter compensatório para a vítima e o pedagógico para o ofensor, bem como a capacidade econômica da ré, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O propósito do valor indenizatório a ser arbitrado tem por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e sim, desestimular a prática desses atos ilícitos, taxando uma sanção pecuniária ao infrator, por ser responsável pelo ato que foi a causa de pedir nesta ação indenizatória, e reparar o dano sofrido por aquele que não deu causa ao evento danoso.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial para:

1. **CONFIRMAR a tutela de urgência** concedida (*Id. 110654586*) e mantida em sede recursal pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, tornando-a definitiva, para **CONDENAR a UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA na obrigação de fazer consistente no fornecimento integral e contínuo do tratamento domiciliar (home care) 24 (vinte e quatro) horas** à Autora

MARIA LINDACI TORRES DI PACE, incluindo equipe de enfermagem 24h, fisioterapia motora e respiratória (3x/semana), fonoaudiologia (2x/semana), nutricionista, visita médica, aparelho de aspiração, dieta enteral hipercalórica e normoproteica (1000 ml/dia), bem como o fornecimento de fraldas geriátricas, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento;

2. **CONDENAR a UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405 do Código Civil);

3. **DETERMINAR que a Ré apresente, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença, planilha detalhada dos custos relativos ao fornecimento dos serviços de home care** à Autora desde o início do cumprimento da tutela de urgência até a data da apresentação da planilha, para fins de apuração do proveito econômico da demanda.

4. Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (somatório do valor dos danos morais e do proveito econômico da obrigação de fazer, a ser apurado em liquidação de sentença), nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João-PB, **data e assinatura eletrônicas**.

Maria Carmen Heráclio do Rêgo Freire Farinha

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA CARMEN HERACLIO DO REGO FREIRE FARINHA
08/01/2026 17:01:32
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131106540

26010817013194300000012

IMPRIMIR GERAR PDF